

Nomor : KJ.02.05/B.III/92/2025

10 Februari 2025

Lampiran : Satu lembar

Hal : Pemberitahuan Perubahan Instrumen
Skrining Kesehatan Jiwa

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka mendukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025, di mana skrining kesehatan jiwa menjadi bagian dari paket pemeriksaan dalam program PKG ini, kami informasikan bahwa instrumen skrining kesehatan jiwa yang digunakan akan mengalami perubahan sebagai berikut :

1. **Untuk sasaran Dewasa dan Lansia:** Menggunakan instrumen PHQ-4 (Patient Health Questionnaire-4), yang terdiri dari 4 pertanyaan. Instrumen ini merupakan kombinasi dari PHQ-2 (Patient Health Questionnaire-2), yang mendeteksi gejala depresi, serta GAD-2 (Generalized Anxiety Disorder-2), yang mendeteksi gejala kecemasan.
2. **Untuk sasaran Ibu Hamil dan Pascamelahirkan:** Menggunakan EPDS (*Edinburgh Postnatal Depression Scale*), yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk mendeteksi gejala gangguan depresi pada ibu hamil dan pascamelahirkan.

Bersama ini, kami lampirkan Petunjuk Teknis Skrining Kesehatan Jiwa sebagai panduan dalam penggunaan instrumen tersebut. Kami berharap Saudara dapat segera menyesuaikan pelaksanaan skrining kesehatan jiwa sesuai dengan kebijakan ini.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok
Rentan,



dr. Imran Pambudi, M.P.H.M

Tembusan:

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran Surat Pemberitahuan
Nomor : KJ.02.05/B.III/92/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Dinas Kesehatan Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu
6. Kepala Dinas Kesehatan Jambi
7. Kepala Dinas Kesehatan Lampung
8. Kepala Dinas Kesehatan Riau
9. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau
10. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung
11. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat
12. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur
13. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan
14. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah
15. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara
16. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Kesehatan Banten
18. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat
19. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah
20. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur
22. Kepala Dinas Kesehatan Bali
23. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur
24. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat
25. Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo
26. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat
27. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah
28. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara
29. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara
30. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan
31. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara
32. Kepala Dinas Kesehatan Maluku
33. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat
34. Kepala Dinas Kesehatan Papua
35. Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah
36. Kepala Dinas Kesehatan Papua Pegunungan
37. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan
38. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok
Rentan,



dr. Imran Pambudi, M.P.H.M

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skrining Kesehatan Jiwa dengan Instrumen *Patient Health Questionnaire* (PHQ-4) pada Dewasa dan Lansia dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai panduan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dalam melaksanakan skrining kesehatan jiwa dengan instrumen PHQ-4 pada dewasa dan lansia dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG).

A. Pelaksanaan Skrining Kesehatan Jiwa dengan Kuesioner PHQ-4 dalam Kegiatan CKG:

Skrining kesehatan jiwa dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan kuesioner PHQ-4 ditujukan untuk sasaran kelompok usia dewasa dan lansia (usia ≥ 18 tahun).

Untuk mendapatkan layanan skrining dalam CKG dengan terlebih dahulu mendaftar menjadi peserta CKG. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga cara sebagai berikut:

1. Aplikasi *Satu Sehat Mobile* (SSM) atau
2. Aplikasi WhatsApp atau
3. Pendaftaran langsung ke Puskesmas melalui website ASIK

Selanjutnya, peserta diminta mengisi kuesioner PHQ-4. Adapun tata cara pengisian kuesioner PHQ-4 sebagai berikut :

- Pengisian kuesioner PHQ-4 melalui *link*/ tautan digital atau dengan scan/ memindai *barcode* yang dilakukan secara mandiri oleh individu peserta skrining. Jika mengalami kesulitan dalam pengisian instrumen secara mandiri, dapat dibantu oleh pendamping/ keluarga/ petugas kesehatan.
- Individu membaca instruksi pengisian instrumen dengan baik, selanjutnya menjawab semua pertanyaan dengan jujur.
- Jawaban pertanyaan berdasarkan kondisi yang dirasakan oleh individu dalam **2 minggu terakhir**.

B. Instrumen Skrining

Instrumen Skrining kesehatan jiwa yang digunakan pada kelompok usia dewasa dan lansia dalam kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah kuesioner *Patient Health Questionnaire* (PHQ-4). Instrumen ini digunakan untuk mendeteksi gejala depresi dan kecemasan. Kuesioner ini terdiri 4 pertanyaan yang merupakan gabungan dari kuesioner *Patient Health Questionnaire-2* (PHQ-2) yang terdiri dari 2 pertanyaan untuk mendeteksi gejala depresi dan kuesioner *Generalized Anxiety Disorder-2* (GAD-2) yang terdiri dari 2 pertanyaan untuk mendeteksi gejala kecemasan.

C. Petunjuk pengisian kuesioner :

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan sesuai dengan perasaan Anda **dalam 2 minggu terakhir**. Berikanlah **tanda centang (✓)** pada pilihan jawaban.

No.	Pertanyaan	Tidak sama sekali	Kurang dari 1 (satu) minggu	Lebih dari 1 (satu) minggu	Hampir setiap hari
PHQ-2					
1.	Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering anda kurang/tidak bersemangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari?				
2.	Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering anda merasa murung, tertekan, atau putus asa?				
GAD-2					
3.	Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering anda merasa gugup, cemas, atau gelisah?				
4.	Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering anda tidak mampu mengendalikan rasa khawatir?				

D. Penilaian Skrining Kesehatan Jiwa dengan Instrumen PHQ-4

1. Skoring jawaban

Skoring jawaban terdiri 4 pilihan jawaban :

- Tidak sama sekali dengan skor 0
- Kurang dari 1 minggu dengan skor 1
- Lebih dari 1 minggu dengan skor 2
- Hampir setiap hari dengan skor 3

Total skor

- Kuesioner PHQ-2 (Subskor depresi) : diperoleh dengan menjumlahkan hasil yang diperoleh dari pertanyaan no. 1 dan 2
- Kuesioner GAD-2 (Subskor kecemasan) : diperoleh dengan menjumlahkan hasil yang diperoleh dari pertanyaan no. 3 dan 4

No.	Pertanyaan	Tidak sama sekali (0)	Kurang dari 1 (satu) minggu (1)	Lebih dari 1 (satu) minggu (2)	Hampir setiap hari (3)	Skor
PHQ-2						
1.	Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering anda kurang/tidak bersemangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari?					
2.	Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering anda merasa murung, tertekan, atau putus asa?					
Total Skor PHQ-2						
GAD-2						
3.	Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering anda merasa gugup, cemas, atau gelisah?					
4.	Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering anda tidak mampu mengendalikan rasa khawatir?					
Total Skor GAD-2						

Keterangan: skoring dalam CKG sudah otomatis dalam sistem sehingga petugas tidak perlu melakukan skoring

2. Interpretasi hasil skrining

Pertanyaan	Total Skor	Interpretasi
PHQ-2 : Subskor Depresi		
No. 1 dan 2	< 3	Tidak ada gejala signifikan
	≥ 3	Menunjukkan kemungkinan gejala depresi
GAD-2 : Subskor kecemasan		
No. 3 dan 4	< 3	Tidak ada gejala signifikan
	≥ 3	Menunjukkan kemungkinan gejala kecemasan

E. Tindak Lanjut

Hasil Skrining	Tindak Lanjut yang Diberikan	Pelaksana
Tidak ada gejala signifikan	Edukasi Kesehatan Jiwa: - Tanda sehat jiwa - Faktor protektif sehat jiwa - Manajemen dan coping stress - Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis (P3LP)	Tenaga Medis (Dokter) dan Tenaga Kesehatan (Perawat, Bidan, Psikolog Klinis)
Menunjukkan Kemungkinan Gejala Depresi dan atau Kecemasan	Konseling awal*	Perawat, Bidan
	- Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk menegakkan diagnosis medis	Dokter, Psikolog klinis
	- Tata laksana sesuai dengan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan puskesmas **	Dokter, Psikolog klinis, perawat
	Rujuk ke FKTL, jika : - Depresi berat atau indikasi membahayakan diri sendiri atau orang lain - Gejala kecemasan tidak membaik > 1 bulan pasca konseling/ tata laksana atau ada indikasi ketergantungan obat cemas	

*Konseling awal: Dapat dilakukan oleh perawat dan bidan yang bersifat suportif sesuai dengan kompetensinya bertujuan mengidentifikasi lebih lanjut gejala-gejala yang dikeluhkan serta membantu mengurangi keluhan.

**Tata laksana sesuai kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas

Demikian petunjuk teknis ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan skrining kesehatan jiwa dengan instrumen PHQ-4 pada dewasa dan lansia dalam CKG, hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

=====

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skrining Kesehatan Jiwa dengan Instrumen *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) pada Ibu Hamil dan Nifas di Puskesmas

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai panduan bagi petugas kesehatan dalam melaksanakan skrining kesehatan jiwa dengan instrumen kuesioner EPDS pada ibu hamil dan nifas di Puskesmas.

A. Pelaksanaan Skrining Kesehatan Jiwa dengan Instrumen EPDS pada Ibu Hamil dan Ibu Nifas

Skrining kesehatan jiwa dengan menggunakan instrumen *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) dilakukan pada Ibu hamil dan nifas sebagai berikut:

Kelompok	Waktu Pemeriksaan	Tenaga Pelaksana
Ibu hamil	Dilakukan 2 kali, yaitu pada: - Trimester I (0-12 minggu): kunjungan pertama (K1) - Trimester III (>28 minggu – kelahiran): kunjungan kelima (K5)	- Bidan - Perawat - Dokter - Psikolog Klinis
Ibu nifas	Dilakukan 1 kali, yaitu pada: pelayanan ibu nifas ketiga pada waktu 8 – 28 hari setelah persalinan (KF-3)	

Pemeriksaan bisa dilakukan lebih dari jadwal waktu pemeriksaan di atas jika diperlukan/atas indikasi.

Tugas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan skrining kesehatan jiwa pada ibu hamil dan nifas, sebagai berikut:

- Menjelaskan cara pengisian kuesioner EPDS termasuk tujuan dan manfaat skrining
- Melakukan penilaian skoring hasil skrining
- Melakukan pencatatan dalam buku KIA
- Melaksanakan tindak lanjut hasil skrining

B. Instrumen Skrining

Instrumen kuesioner *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) adalah instrumen yang digunakan untuk mendeteksi gejala gangguan depresi pada ibu hamil dan nifas yang terdiri dari 10 pertanyaan.

Petunjuk pengisian kuesioner:

Karena Anda saat ini hamil atau pascamelahirkan, kami ingin mengetahui bagaimana perasaan anda sekarang.

Silakan memilih jawaban yang paling mirip dengan perasaan anda selama **7 hari** terakhir, tidak hanya perasaan anda hari ini.

No	Pertanyaan	No.	Pertanyaan
1.	Saya dapat tertawa dan melihat segi kelucuan hal-hal tertentu: a. Seperti biasanya b. Sekarang tidak terlalu sering c. Sekarang agak jarang d. Tidak sama sekali	6.	Banyak hal menjadi beban untuk saya: a. Ya, seringkali saya sama sekali tidak dapat mengatasinya b. Ya, kadang saya tidak dapat mengatasi seperti biasanya c. Tidak, biasanya saya dapat mengatasinya dengan baik d. Tidak, saya dapat mengatasinya dengan baik seperti biasanya
2.	Saya menanti-nanti untuk melakukan sesuatu dengan penuh harapan: a. Hampir seperti biasanya b. Agak berkurang dari biasanya c. Jelas berkurang dari biasanya d. Hampir tidak sama sekali	7.	Saya merasa begitu sedih sampai sulit tidur: a. Ya, hampir selalu b. Ya, kadang-kadang c. Tidak, tidak sering d. Tidak, tidak pernah
3.	Saya menyalahkan diri sendiri jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik: a. Ya, hampir selalu b. Ya, kadang-kadang c. Tidak terlalu sering d. Tidak, tidak pernah	8.	Saya merasa sedih atau susah: a. Ya, hampir selalu b. Ya, sering c. Jarang d. Tidak pernah
4.	Saya merasa cemas atau khawatir tanpa alasan: a. Tidak, tidak sama sekali b. Hampir tidak pernah c. Ya, kadang-kadang d. Ya, amat sering	9.	Saya merasa sangat sedih sehingga saya menangis: a. Ya, hampir selalu b. Ya, sering c. Hanya sekali-kali d. Tidak pernah
5.	Saya merasa takut atau panik tanpa alasan: a. Ya, sering sekali b. Ya, kadang-kadang c. Tidak, tidak terlalu d. Tidak, tidak pernah sama sekali	10.	Pikiran untuk mencelakai diri sendiri sering muncul: a. Ya, agak sering b. Kadang-kadang c. Hampir tidak pernah d. Tidak pernah

C. Pengisian Skrining Kesehatan Jiwa oleh Ibu Hamil dan Nifas dengan Instrumen Kuesioner EPDS

Pengisian dilakukan secara mandiri melalui *link/* tautan digital yang disediakan. Namun jika pengisian melalui *link/* tautan digital terjadi kendala, maka dapat dilakukan pengisian secara manual dengan menggunakan kertas form kuesioner EPDS yang dicetak.

Adapun tata cara pengisian instrumen kuesioner EPDS sebagai berikut :

1. Tenaga medis dan tenaga kesehatan menjelaskan tujuan dan manfaat skrining dan meminta kepada ibu agar mengisi kuesioner secara mandiri tentang perasaan yang terdekat dengan pertanyaan yang tersedia dalam **7 hari terakhir**.
2. Ibu harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur.
3. Jawaban kuesioner harus berasal dari ibu sendiri. Hindari kemungkinan ibu mendiskusikan pertanyaan dengan orang lain.
4. Ibu harus menyelesaikan kuesioner ini sendiri, kecuali ia mengalami kesulitan dalam memahami bahasa atau tidak bisa membaca dapat dibantu oleh pendamping/ keluarga/ nakes.

D. Penilaian Skrining Kesehatan Jiwa dengan Instrumen Kuesioner EPDS

1. Skoring jawaban

Setiap pertanyaan memiliki empat pilihan yang mungkin, yang diberi nilai dari 0 sampai 3

- a. Pertanyaan 1,2, dan 4 : mendapatkan nilai 0, 1, 2, atau 3 dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 0 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 3
- b. Pertanyaan 3,5 sampai dengan 10: merupakan penilaian terbalik, dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 3 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 0
- c. Pertanyaan 10 merupakan pertanyaan yang menunjukkan keinginan bunuh diri

Total skor akan muncul secara otomatis jika skrining dilakukan secara digital. Namun jika skrining dilakukan secara manual, maka harus dilakukan perhitungan skoring oleh petugas.

Agar lebih memudahkan penghitungan skoring, petugas kesehatan dapat melihat format penilaian pada tabel dibawah ini.

No	Pertanyaan	Skor	No.	Pertanyaan	Skor
1.	Saya dapat tertawa dan melihat segi kelucuan hal-hal tertentu: a. Seperti biasanya b. Sekarang tidak terlalu sering c. Sekarang agak jarang d. Tidak sama sekali	0 1 2 3	6.	Banyak hal menjadi beban untuk saya: a. Ya, seringkali saya sama sekali tidak dapat mengatasinya b. Ya, kadang saya tidak dapat mengatasi seperti biasanya c. Tidak, biasanya saya dapat mengatasinya dengan baik d. Tidak, saya dapat mengatasinya dengan baik seperti biasanya	3 2 1 0
2.	Saya menanti-nanti untuk melakukan sesuatu dengan penuh harapan: a. Hampir seperti biasanya b. Agak berkurang dari biasanya c. Jelas berkurang dari biasanya d. Hampir tidak sama sekali	0 1 2 3	7.	Saya merasa begitu sedih sampai sulit tidur: a. Ya, hampir selalu b. Ya, kadang-kadang c. Tidak, tidak sering d. Tidak, tidak pernah	3 2 1 0
3.	Saya menyalahkan diri sendiri jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik: a. Ya, hampir selalu b. Ya, kadang-kadang c. Tidak terlalu sering d. Tidak, tidak pernah	3 2 1 0	8.	Saya merasa sedih atau susah: a. Ya, hampir selalu b. Ya, sering c. Jarang d. Tidak pernah	3 2 1 0
4.	Saya merasa cemas atau khawatir tanpa alasan: a. Tidak, tidak sama sekali b. Hampir tidak pernah c. Ya, kadang-kadang d. Ya, amat sering	0 1 2 3	9.	Saya merasa sangat sedih sehingga saya menangis: a. Ya, hampir selalu b. Ya, sering c. Hanya sekali-kali d. Tidak pernah	3 2 1 0
5.	Saya merasa takut atau panik tanpa alasan: a. Ya, sering sekali b. Ya, kadang-kadang c. Tidak, tidak terlalu d. Tidak, tidak pernah sama sekali	3 2 1 0	10.	Pikiran untuk mencelakai diri sendiri sering muncul: a. Ya, agak sering b. Kadang-kadang c. Hampir tidak pernah d. Tidak pernah	3 2 1 0
Skor			Skor		
			Total Skor		

2. Interpretasi hasil skrining

Nilai maksimal dari pengisian kuesioner ini adalah 30. Hasil skrining kesehatan jiwa dengan instrumen EPDS dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Total Skor	Interpretasi
0-12	Tidak menunjukkan gejala signifikan
≥ 13	Terindikasi/menunjukkan kemungkinan gejala depresi

E. Tindak Lanjut

Tindak lanjut skrining kesehatan jiwa dengan instrumen EPDS pada ibu hamil dan nifas sebagai berikut :

Hasil Skrining	Tindak Lanjut	Pelaksana
• skor 0-12 (Tidak menunjukkan gejala signifikan)	• Edukasi Kesehatan Jiwa: - Tanda sehat jiwa pada Ibu - Faktor protektif sehat jiwa - Latihan Manajemen dan <i>coping stress</i> - Pengasuhan positif • Skoring 9-12: skrining ulang pada kunjungan ANC berikutnya	• Bidan • Perawat • Dokter • Psikolog Klinis
• skor ≥ 13 (Terindikasi/ menunjukkan kemungkinan gejala depresi) • skor kurang dari 13 namun memilih jawaban “agak sering” untuk pertanyaan no.10	Konseling awal*	Perawat, Bidan
	Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk menegakkan diagnosis	Dokter, Psikolog klinis
	Tata laksana sesuai dengan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan puskesmas**	Dokter, Psikolog klinis, Perawat
	Rujuk ke FKTL, jika: Depresi berat atau indikasi membahayakan diri sendiri atau orang lain.	

*Konseling awal: Dapat dilakukan oleh perawat dan bidan yang bersifat suportif dengan tujuan mengidentifikasi lebih lanjut gejala-gejala yang dikeluhkan dan mengurangi keluhan.

**Tata laksana sesuai kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas

Demikian petunjuk teknis ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan skrining kesehatan jiwa dengan menggunakan instrumen kuesioner EPDS pada ibu hamil dan nifas di puskesmas, hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
